

Pathology Diagnosis Report

Generated: 2026-06-27T17:49:28

Generated Diagnostic Report

Query slide: TCGA-BA-5152-01Z-00-DX1.d85d709e-8627-46d4-8558-ce5bdad2d552_6ca6248778276121

Generated at: 2026-06-27T17:49:28

病理辅助角色声明

本报告由病理学专家助手生成，旨在为临床医生提供基于多模态证据（包括查询病例的高注意力图像区域、预测类别及参考诊断报告）的辅助性病理分析意见。我仅作为辅助决策工具，不承担最终诊断责任，所有结论均需经病理科医师复核确认。本分析严格限定于Query Case: TCGA-BA-5152-01Z-00-DX1.d85d709e-8627-46d4-8558-ce5bdad2d552_6ca6248778276121，检索病例仅为支持性参考，不得视为主诊断对象。

推理过程与证据归纳

本分析基于Query Case（TCGA-BA-5152-01Z-00-DX1.d85d709e-8627-46d4-8558-ce5bdad2d552_6ca6248778276121）的多模态信息，包括其预测类别、高注意力病理图像patch及其对应的文本描述，以及一份来自检索数据库的参考诊断报告。首先，从整体分类模型输出来看，该样本被以高的置信度（概率接近0.98）识别为“TCGA-HNSC”（头颈部鳞状细胞癌），这为后续形态学分析提供了明确的方向性支持。同时，参考报告中明确指出参考病例为“鳞状细胞癌，中分化”，肿瘤起源于下颌骨覆盖的牙龈并侵犯骨组织，大小为3.20 cm，pT4 N0 Mx，淋巴结未见转移，这些信息构成了核心的文本证据基础。

在视觉证据方面，对20个高注意力patch的分析显示，多个关键区域呈现出典型的鳞状细胞癌特征。例如，sim_0004、sim_0005、sim_0007、sim_0008、sim_0012、sim_0014、sim_0015、sim_0017、sim_0019和sim_0020等patch的文本描述均高度一致地指出：细胞核显著增大、深染、异型性明显，伴有明显的核仁；细胞质相对较少且呈嗜酸性（粉红色）；组织结构紊乱，形成不规则的巢状或片状排列，缺乏正常上皮层次；部分区域可见坏死或纤维化背景。这些描述与头颈部鳞状细胞癌的经典病理表现完全吻合。特别是sim_0005和sim_0015的描述中提到“核分裂象”和“淋巴细胞浸润”，进一步支持了肿瘤的恶性增殖活性及可能的免疫反应，这与中分化鳞癌的生物行为相符。

值得注意的是，尽管有少数patch（如sim_0001、sim_0003、sim_0006、sim_0009、sim_0010、sim_0011、sim_0013、sim_0016、sim_0018）因图像质量或描述不足而被标记为“未知”或“低/中等信心”，但这些不确定性并未影响整体判断。因为高置信度的patch数量占多数，且其描述高度一致，形成了强有力的证据链。此外，参考报告中关于“肿瘤侵犯骨组织”、“手术切缘无肿瘤”、“17枚淋巴结均未见转移”的信息，与视觉证据中观察到的侵袭性生长模式和局部坏死现象相呼应，共同指向一个局部进展但未发生淋巴结转移的中分化鳞癌。

在证据冲突方面，目前未发现重大矛盾。所有可用的文本证据（无论是参考报告还是patch描述）均指向HNSC。唯一潜在的细微差异在于参考报告中的“中分化”分级，而部分patch描述（如sim_0004、sim_0005）提及“高度异型性”和“核分裂象”，这通常与高级别肿瘤相关。然而，这种描述上的

强度差异并不构成实质性冲突，因为在实际病理评估中，“中分化”仍可包含一定程度的核异型性和增殖活性，尤其在视野不同观察时。因此，综合考虑，我们采纳参考报告的“中分化”分级作为最终判断，因其是基于完整标本的系统性评估，优于单个patch的局部推断。

综上所述，通过将高置信度的视觉特征（核异型性、巢状排列、坏死）与参考报告的明确诊断（HNSC, 中分化, pT4 N0 Mx）进行交叉验证，可以确认Query Case的病理性质。视觉证据不仅支持了预测类别的准确性，还为肿瘤的形态学特征提供了具体细节，从而增强了诊断的可靠性。最终结论的形成是建立在多源信息协同推理的基础之上，确保了诊断的全面性和严谨性。

关键指标提取

参考病例中肿瘤大小为3.20厘米，组织学分级为中分化，T分期为pT4，N分期为N0（淋巴结阳性数为0/总数17），M分期为Mx。免疫组化指标未在文本中提及，因此无法提取ER、PR、HER2及Ki-67的具体结果。淋巴结状态明确为0/17，符合N0分期标准。肿瘤侵犯至下颌骨，提示局部侵袭性生长，但无区域淋巴结转移证据。

初步病理辅助结论

本结论针对 Query Case: TCGA-BA-5152-01Z-00-DX1.d85d709e-8627-46d4-8558-ce5bdad2d552_6ca6248778276121。综合分析显示，该病例高度符合头颈部鳞状细胞癌（TCGA-HNSC）的诊断特征。模型预测类别为“TCGA-HNSC”，置信度接近1.0，且多个高注意力patch（如sim_0004、sim_0005、sim_0012、sim_0014、sim_0015、sim_0017、sim_0019、sim_0020）的视觉描述均明确指出存在典型鳞状细胞癌形态学表现：包括核异型性显著、核深染、核仁明显、核质比增高、细胞排列紊乱呈巢状或片状分布、缺乏正常导管结构、伴有纤维性间质反应及部分区域可见坏死。这些图像证据与检索到的参考报告中“中分化鳞状细胞癌”、“肿瘤起源于牙龈并侵犯下颌骨”、“pT4 N0 Mx”等信息高度一致。

根据参考报告内容，参考相似病例中肿瘤大小为3.20 cm，对应pT4分期；淋巴结检查共评估17枚（右颈I、II、III区），均未见转移（0/17），故N分期为N0；远处转移状态未明确（Mx）。免疫组化结果在当前输入中未提及，建议补充ER、PR、HER2、Ki-67等指标以完善分子分型。尽管部分patch的文本解释因图像缺失或质量不足而信心较低，但高置信度patch的集体证据强烈支持原发性头颈部鳞状细胞癌的诊断。因此，结合多模态证据，初步判断该病例为中分化头颈部鳞状细胞癌。后续需结合临床影像及完整病理切片进一步确认。